건강과 사회 그리고 심리학

(Health, Society, and Psychology)

한양대 학부 교양 2026년 2학기

제1공학관 103호 / 수 11:00~12:50

목차

05. 심리치료

제15장 정신장애의 치료 (심리학입문)

제16장 치료 (마이어스의 심리학)

✔심리치료(psychotherapy)

✔생의학치료(biomedical therapy)

05. 심리치료
제15장 정신장애의 치료 (심리학입문)
제16장 치료 (마이어스의 심리학)

• **정신장애의 치료**

○ 심리치료(psychotherapy) : 상담자(치료사)와의 상호작용을 통한 마음 치유

○ 생의학치료(biomedical therapy) : 뇌를 통한 마음 치유로 약물치료나 생물학적 처치

➜ 뇌과학의 발달(생리학적 · 화학적 측면에 대한 정보 증가)로 뇌에서 시작되는 정신건강에 대한 접근법이 점점 확대되는 중

✔심리치료(psychotherapy)

■ 정신역동 이론

● 전통적인 정신분석(psychoanalysis)

○주 4~5회, 약 3~6년에 걸쳐 진행

○장의자(카우치)에 누워 분석가의 가이드에 따라 마음에 떠오르는 것은 무엇이든 모두 말하도록 함

○무의식의 소망, 동기, 갈등을 반영하는 심층적 이슈를 만나게 되고 자신의 무의식적 마음이 어떻게 작동하는지에 대한 통찰을 얻게 됨

○정신분석의 목표는 자신의 무의식을 이해하는 것



내담자는 장의자에 눕고 치료자는 뒤에 앉음

● 정신분석적 치료

○ 내용과 절차 측면에서 전통적인 정신분석과 다름

○ 내담자 스스로 자신의 현재 증상을 이해하는 것을 돕고자 시도

○ 아동기 경험과 치료사와의 관계를 포함, **중요한 관계에 걸쳐 있는 주제에 초점**

▸ 대인관계치료(interpersonal psychotherapy, IPT)

○ 치료자와 내담자는 얼굴을 마주 보고 앉음

○ 내담자의 현재 관계의 개선에 중점을 두는 심리치료

○ 내담자에게 대인관계 행동이나 감정을 이야기하게 하는 IPT 대화법을 사용

■ 인본주의

○ 인간의 긍정적인 본성을 가정하며 성장을 위한 개인의 노력을 강조

○ 심리적인 문제는 소외감과 외로움에서 기인한 것으로, 이런 감정들은 자신의 잠재력에 도달하는 것에 실패했거나 삶에서 의미를 찾는 데 실패했기 때문

● 인간 중심 치료(person-centered therapy)

○ 모든 사람은 성장하려 하며, 이 성장이 치료자의 수용과 진실된 반응으로 촉진될 수 있다고 가정

○ 병을 치료하는 것이 아니라 **성숙을 도모하는 것이 치료의 초점**

○ 성숙으로 나아가는 길은 자신의 감정과 행위에 대해 책임을 지는 것

○ 의식적 사고가 무의식적 사고보다 더 중요

○ 과거보다는 현재와 미래가 더 중요

○ 상담자는 내담자가 무엇을 해야 하는지에 대한 충고나 제안을 하지 않음(내담자가 생각이나 감정을 자유롭게 표현하도록 한다는 점에서는 정신분석과 유사함)

■ 행동주의와 인지주의

○ 내담자의 정신병리를 완화하거나 극복하려는 목적으로 현재 보이는 사고와 행동을 실제로 바꾸고자 함

● 행동치료(behavior therapy) : 부적절한 행동 패턴을 변화시키기

○ 행동주의 원칙은 관찰가능한 증상에만 관심 (예: 비행기를 타지 못하는 것과 같은 공포 대상에 대한 회피)

○ 질병 행동은 학습된 것이며 관찰가능한 부적응적 행동을 보다 생산적인 행동으로 바꾸는 것을 통해 증상 완화가 가능하다고 가정

▸ 강화와 처벌

○ 세 살짜리 남자아이가 가게에서 떼쓰기 행동을 보인다면 어떻게 하겠는가?

→ 행동치료자는 떼쓰기 직전과 직후에 어떤 일이 일어나는지 조사

➜ 행동을 강화하지 않고(사탕을 주지 않음), 처벌(타임아웃)을 제공하는 것으로 문제행동을 제거

▸ 토큰 경제(token economy)

○조현병을 가진 사람을 어떻게 좀 더 일상 활동을 하게 만들 수 있을까?

○코카인 중독자를 어떻게 약을 끊게 할 수 있을까?

➜내담자가 바람직한 행동을 하는 경우 '토큰'을 주고, 내담자는 나중에 이를 보상과 바꿀 수 있음

◦ 코가인 중독 예 : 바람직한 행동(코카인 미사용)

→토큰 제공(돈이나 패스, 옷 등의 보상으로 바꿀 수 있는 바우처)

→**코카인 사용의 유의미한 감소**

◦ 교실, 산업현장, 상업광고 등에서도 바람직한 행동 증가를 위해 사용 가능 (예 : 비행기나 크레딧 카드 보상 프로그램 등)

▸ 노출치료(exposure therapy)

○감정을 유발하는 **자극을 직접적으로 & 반복적으로 직면**하게 함으로써 감정 반응을 줄이는 방법

○공포 : 강력한 방법은 공포스러운 물건이나 상황에 대한 점진적인 노출

○습관화와 반응소거 과정에 의거함

◦ 크리스틴 사례 : 강박 사고(먼지나 세균)에 점차적으로 노출

→반복 노출로 인해 먼지나 세균으로부터 점점 덜 고통

→이전에 두려워했던 자극에 노출되어도 해를 입지 않는다는 것을 배움

• 노출 위계

○사회적 상호작용이 두려워 학교나 직장에서 기능을 못하는 사람

◦ 한 사람과 짧게 대화하는 것을 상상

→중간 크기의 집단에서 좀 더 길게 말하기

→큰 집단에서 연설하는 것에 노출

▸ 체계적 감감법/둔감화

○ 지속적인 불안 반응은 학습된 반응

○ **역조건형성(counterconditioning) 원리** : 생리적으로 공존할 수 없는 새로운 반응을 학습시키는 것을 통해 불안을 억제

○ Jacobson의 **점진적 이완 훈련**

- ◦ 긴장을 이완시키면 생리적 긴장이 감소된다는 원리
- ◦ 불안을 야기하는 자극에 대한 상상을 통해 대응하게 함으로써 훈련 (구체적/실제적인 자극, 사회적 상황, 과거/미래의 상황, 자극의 강도도 통제 가능)

①1단계 : 불안의 위계의 작성

○ **고통스러운 정서적 각성과 회피를 유발하는 상황을 확인**

○ **불안 위계 심도 작성** : 불안의 정도에 따라 자극의 등급을 매김

- ◦ 정상적인 불안 반응(현실 불안)은 제외 가능
- ◦ 불안 야기력 정도에 따라 위계적으로 목록화(불안을 가장 약하게 일으키는 것부터 가장 강하게 일으키는 것까지 목록화, 내용과 정도에 따라)
- ◦ 몇 개의 범주로 이루어지는 복합적 위계도 있을 수 있음(각 범주에 따라 별도의 위계표 작성)
- ◦ 현 생활에서 가장 강한 불안을 일으키는 상황/사건부터 시작
- ◦ 위계표는 구체적으로 작성 (예: 고소공포증이라면 지상층, 2층, 3층 …)

②2단계 : 근육의 긴장 이완

○양립할 수 없는 반응을 훈련 : 이완 반응은 불안과 양립 불가능 & 학습 가능

○과정

- **신체 부위를 긴장시킴**(손, 팔, 어깨, 목, 머리) → **스스로 이완**
- 완전히 평온해지고 최면에 가까운 상태의 깊은 근육 이완이 될 때까지 학습
- 국부적 근육을 긴장했다가 푸는 것에 세심한 주의

○주의

- 근육을 긴장시켜서 풀 때까지 그 근육에 정신 집중
- 긴장 풀 때는 **갑작스럽게 풀기**
- 긴장시켰을 때와 이완됐을 때의 차이를 생생하게 감상

- **3단계 : 체계적 감감/둔감**

○원리 : 자극과 불안 반응 간 연합은 감소, 자극과 이완 반응 간 연합은 강해짐

○사전 점검 : 자극

- ◦ 상상적 제시가 불안을 일으키는가
- ◦ 환자가 불안야기상황에 있는 자신을 상상할 수 있는가
- ◦ 상상의 시작과 종료에 응할 수 있는가

○사전 점검 : 이완훈련 후

- ◦ 중립적인 상황과 가장 즐겁고 유쾌했던 경험을 상상해보게 함(상상의 자유)
- ◦ 이완 상태에서 긴장 이완, 중립적 상황과 유쾌한 경험 상상을 쉽게 수행할 수 있는지 확인, 이 세 조건이 만족스러우면 감감 절차에 들어감.

○ 실시 절차

- 깊게 이완한 상태에서 불안 위계 심도에서 최소의 불안 유발 자극을 제시 (언어적 or 그림 등 상징적으로 → 실전)
- 충분히 상상하도록 하며, 자극이 제시된 동안 이완되고 평온한 상태 유지
- 점차 높은 불안 자극으로 이동
- 높은 위계 훈련 중에는 이완을 위해 가장 생생한 심상을 형성(예: 고소공포증이라면, 높은 곳에서 비상구를 따라 내려오는 것까지 생생하게 심상화)
- 평온한 채로 각 항목에 집중할 수 있게 되면, 마지막 위계까지 진행(예: 옥상 위에서 아래를 내려다 봄)

○ 주의 사항

- 조금이라도 긴장, 불쾌감, 불안을 느끼면 신호를 보내게 함
- 불안해지면 상상을 중단하고 긴장을 푼 다음, 평온해지면 쉬운 위계로 이동
- 매번 성공 상태로 마치고, 다음에는 그전 시간에 끝난 위계에서 시작

● 인지치료(cognitive therapy) : 왜곡된 사고를 변화시키기

○ 내담자가 자신과 타인 그리고 세상에 대한 왜곡된 사고를 인식하고 수정하는 데 초점

○ 공포증에 대한 설명

- ◦ 행동주의 : 고전적 조건형성의 결과 (개에게 물린 경험 → 개와 고통의 경험의 연결을 통해 개 공포증으로 발전)
- ◦ 인지주의 : 이 사건에 대한 해석을 강조 (개에게 물린 이후 “개는 너무 위험하다"는 새롭고 강력한 믿음이 중요)

➜ **인지적 재구조화(cognitive restructuring)** : 내담자에게 부정적 감정을 유발하는 자동적 사고, 가정과 예측에 대해 스스로 질문하게 가르치고 이 부정사고를 보다 현실적이고 긍정적인 믿음으로 바꿀 수 있게 돕는 방법

● 인지행동치료(cognitive behavioral therapy, CBT) : 접근법의 결합

○ 인지치료와 행동치료 전략을 결합한 치료

○ 문제 중심 : 특정 문제를 다룸(예 : 공황 발작의 빈도를 줄이고, 우울증에서 회복해서 다시 일터로 복귀하는 것)

○ 행동 지향 : 치료자가 환자가 이런 문제를 다룰 수 있는 특정 전략을 선택하게 도움

- ◇ 예: 노출 연습, 행동변화 기술 적용, 증상에 관한 일기 작성 등의 과제 부여

■ 집단치료 : 동시에 여러 사람을 치료하기

● 커플치료와 가족치료

○ 결혼, 동거, 연애 중인 커플이 관계 안에서 일어나는 문제를 해결하기 위해 함께 치료를 받는 것

○ 문제는 커플 중 한 사람 때문이라기보다는 관계에서 발생

○ 반복되는 역기능적 패턴을 바꿈으로써 양쪽 모두의 변화를 목적으로 함

● 집단치료(group therapy)

○ 여러 명의 참가자들이 **집단 내에서 자신의 문제를 해결**하는 방법

○ 집단원들 간 상호 작용을 통해서 치료 효과를 얻을 수 있음

- ◦ 시간과 경제적 부담 감소
- ◦ 다른 사람들도 자신과 같은 문제를 겪고 있다는 사실을 통해 안도감 경험
- ◦ 사회적 행동을 탐구하고 사회적 기술을 개발하는 현장 실험실을 제공
- ◦ 새로운 행동 방식을 시도할 때 피드백 제공

● 자조 및 지지집단

○ 주로 유사한 문제로 어려움을 겪었던 구성원들에 의해 운영

○ 각각의 **개인적인 성공 경험을 바탕으로 서로에게 지도와 지지**를 제공

- ◦ 익명의 알코올중독자들 (Alcoholics Anonymous, AA)
- ◦ 익명의 도박중독자들(Gamblers Anonymous, GA)
- ◦ AA 가족모임(음주 문제를 가진 사람의 가족이나 친구를 위한 프로그램)

- ◦ 암 생존자, 자폐아 부모, 기분장애, 섭식장애, 약물 중독 등

✔생의학치료(biomedical therapy)

■ 약물치료

● 항정신성 약물(antipsychotic drug)

○조현병과 관련된 정신증을 치료하는 데 사용하는 약물

- ◦ 정적 증상(환각이나 망상 등) : 도파민 과다와 관련
- ◦ 부적 증상(무감정 및 사회적 위축 등) : 도파민 저활성화와 관련
- ◦ 인지적 지각적 문제와 감정 저해 등 : 뇌에서 세로토닌 활동 증가와 관련

○전형적/전통적 항정신성 약물(클로르프로마진) : 뇌의 특정 부위의 도파민 수용기를 차단(이 영역의 도파민 활동을 줄임), 정적 증상 완화에 효과적

- ◦ 부작용 : 굼뜬 행동, 떨림, 경련 (파킨슨병 환자에게 엘도파 투여 시 환각)

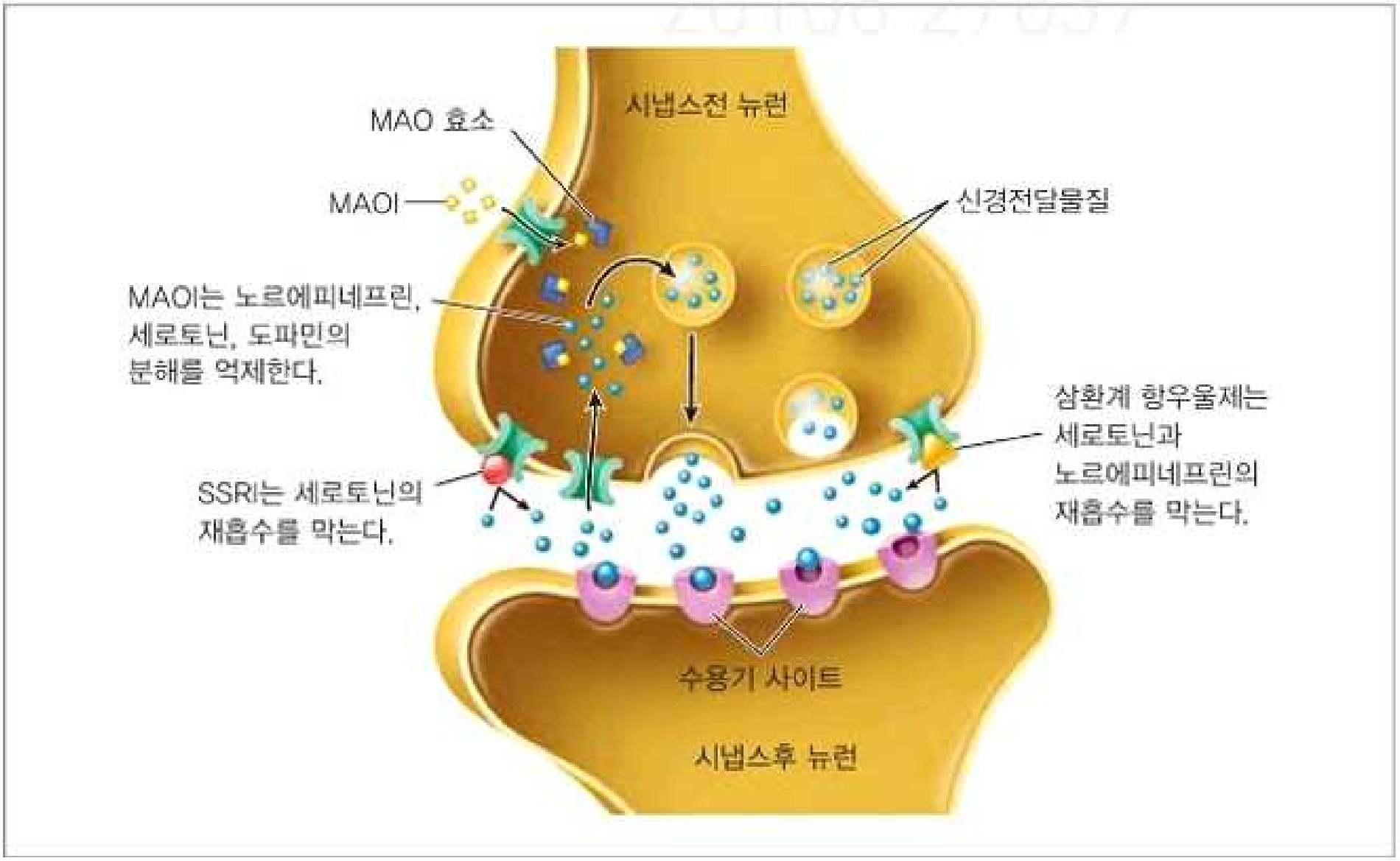
○비전형적 항정신성 약물(클로자핀, 리스페리돈, 올란제핀 등) : 도파민과 세로토닌 수용기를 차단, 부적 증상에도 효과적

● 항불안제(antianxiety medications)

○ 공포나 불안 경험을 줄이는 데 도움이 되는 약물

○ 벤조디아제핀(benzodiazepines) : 신경전 달물질인 GABA (Gamma-aminobutyric acid)의 활동을 활성화하는 진정제의 한 종류

• 항우울제(antidepressant)와 기분안정제



▸ 항울제

○ MAO (monoamine oxidase inhibitor) 억제제

○ 삼환계 항우울제(tricyclic antidepressants)

○ 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs) : 뇌에서 세로토닌의 재흡수를 방해(낮은 세로토닌 수준이 우울의 원인이 된다는 가정) / 플루옥세틴(프로작), 시탈로프람(세렉사), 파록세틴(팍실) 등

○ 세로토닌과 노르에피네프린 재흡수 억제제 : 에펙서

○ 노르에피네프린과 도파민 재흡수 억제제 : 웰뷰트린

▸ 기분안정제

○ 양극성 장애의 경우 항울제 사용 시 기분을 올리는 과정에서 조증 에피소드를 유발할 가능성이 있기 때문에 기분안정제를 사용

○ 예: 리튬과 발프로에이트

■ 약물 이외의 생물학적 치료

● 전기충격요법(electroconvulsive therapy, ECT)

○ 뇌에 전기 충격을 가함으로써 짧은 발작을 유발시키는 방법

○ 양극성 장애, 심한 우울증 등

● 두개골 간 자기 자극법(transcranial magnetic stimulation, TMS)

○ 강력한 전극을 띤 자기를 환자의 뇌에 심어 뇌의 신경활동을 변화시키는 치료

○ 비침투적이고 부작용이 적은 편

● 정신외과술(psychosurgery)

○ 특정 뇌 부위를 외과적으로 파괴하는 것

● 뇌 자극법(deep brain stimulation, DBS)

○ 관련 있다고 생각되는 뇌의 특정 부분에 전기자극을 하는 방법